PROJETO GABARITANDO

VEM GABARITAR COM A GENTE

APOSTILA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE (CCIRAS)

Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins

Cargo: Técnico em Enfermagem · Assunto 18 do edital · 2026

"O crescimento mora no desconforto."

@projeto.gabaritando

1. RESUMO TEÓRICO

18.1 Base legal

A **Lei nº 9.431/1997** obriga os hospitais do país a manter um **Programa de Controle de Infecções Hospitalares (PCIH)** e a criar uma **Comissão de Controle de Infecções Hospitalares (CCIH)**. A **Portaria GM/MS nº 2.616/1998** regulamenta as diretrizes e normas para a prevenção e o controle das infecções hospitalares. Com a ampliação do conceito para **Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS)** – que podem ocorrer em hospitais, ambulatórios, serviços de diálise, atenção domiciliar e outros –, muitos serviços e estados passaram a usar a denominação **CCIRAS**. A ANVISA coordena o **Programa Nacional de Prevenção e Controle de IRAS (PNPCIRAS)**.

Programa de Controle de Infecção Hospitalar (PCIH): conjunto de ações desenvolvidas deliberada e sistematicamente com vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções hospitalares.

18.2 Composição da comissão (Portaria 2.616/1998)

A CCIH/CCIRAS é composta por dois tipos de membros:

Tipo	Quem são	Função
Membros consultores	Representantes dos serviços **médico, de enfermagem, de farmácia, de microbiologia (laboratório) e da administração**	Definem as diretrizes, aprovam o programa e as normas
Membros executores	Representam o **Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH)**; no mínimo **2 técnicos de nível superior** da área da saúde para cada **200 leitos** ou fração, sendo **1 deles preferencialmente enfermeiro**	Executam as ações programadas do controle de infecção

Carga horária mínima dos executores: **6 horas diárias** para o enfermeiro e **4 horas diárias** para os demais profissionais, com ampliação nos hospitais com leitos destinados a pacientes críticos (UTI, berçário de alto risco, queimados, transplante, onco-hematologia, aids): a comissão deve ser acrescida de outros profissionais de nível superior, e os executores têm **2 horas semanais** a mais para cada **10 leitos críticos** ou fração.

O **presidente** da comissão é indicado pela direção da instituição, e a comissão deve ter regimento interno.

18.3 Competências da CCIH/CCIRAS

- Elaborar, implementar, manter e avaliar o **programa de controle de infecção**, adequado às características da instituição.
- Implantar e manter um **sistema de vigilância epidemiológica** das infecções, preferencialmente **busca ativa** (método recomendado pela portaria).
- Realizar **investigação epidemiológica de casos e surtos**, implantando medidas imediatas de controle.
- Elaborar e divulgar **relatórios periódicos** com taxas e indicadores à direção e às chefias.
- Propor e cooperar na elaboração de **normas e rotinas técnico-operacionais** (precauções, isolamento, limpeza, processamento de artigos, procedimentos invasivos).
- Promover **treinamento e capacitação** dos profissionais (educação permanente).

- Elaborar a **política de uso racional de antimicrobianos**, germicidas e materiais médico-hospitalares, em conjunto com a farmácia (controle de antibióticos restritos, padronização).
- **Notificar** ao órgão de gestão do SUS os casos de doenças de notificação compulsória e surtos diagnosticados ou suspeitos.
- Definir, junto à CME e ao serviço de limpeza, a padronização de **saneantes** e de processamento de artigos.
- Cooperar com a ação de fiscalização da vigilância sanitária.

18.4 Vigilância e indicadores de IRAS

Classificação clássica das infecções (Portaria 2.616/1998):

- **Infecção comunitária (IC):** constatada ou em incubação no ato de admissão, desde que não relacionada a internação anterior no mesmo hospital. Também é comunitária a infecção do RN transmitida por via **transplacentária** (toxoplasmose, rubéola, sífilis, citomegalovírus, HIV) e a associada a **bolsa rota superior a 24 horas**.
- **Infecção hospitalar (IH):** adquirida após a admissão do paciente, manifestada durante a internação ou após a alta, quando puder ser relacionada à internação ou a procedimentos hospitalares. Critério prático: manifestação após **72 horas** da admissão quando o período de incubação for desconhecido; antes de 72 h, quando associada a procedimentos invasivos realizados após a admissão. No RN, são hospitalares todas as infecções, **exceto** as transmitidas de forma transplacentária e as associadas à bolsa rota > 24 h.

Principais indicadores:

- **Taxa de infecção hospitalar** = (nº de infecções hospitalares ÷ nº de saídas – altas, óbitos e transferências) × 100.
- **Taxa de pacientes com infecção** = (nº de pacientes com IH ÷ nº de saídas) × 100.
- **Densidade de incidência** de infecções associadas a dispositivos = (nº de infecções ÷ nº de **paciente-dia** em uso do dispositivo) × 1.000. Ex.: IPCS por 1.000 cateteres centrais-dia; PAV por 1.000 ventiladores mecânicos-dia; ITU por 1.000 sondas vesicais-dia.
- **Taxa de utilização de dispositivo** = dispositivo-dia ÷ paciente-dia.
- Taxa de infecção de sítio cirúrgico por **potencial de contaminação** da cirurgia (limpa, potencialmente contaminada, contaminada e infectada). A taxa de ISC em **cirurgias limpas** é o melhor indicador da qualidade da assistência cirúrgica (esperada abaixo de 2% a 5%).
- Perfil de sensibilidade microbiana e consumo de antimicrobianos.

18.5 Classificação das cirurgias por potencial de contaminação

Classe	Definição	Exemplos
Limpa	Tecidos estéreis ou de fácil descontaminação, sem processo infeccioso e sem penetração em tratos colonizados	Cirurgias cardíacas, neurocirurgias, ortopédicas sem fratura exposta, herniorrafia, tireoidectomia
Potencialmente contaminada	Penetração em tratos digestório, respiratório ou urinário com colonização, sem contaminação significativa	Colecistectomia sem inflamação aguda, histerectomia, cirurgias gástricas
Contaminada	Tecidos recentemente traumatizados e abertos, colonizados por flora abundante, ou com falha técnica grosseira	Cirurgias de cólon, fratura exposta recente, apendicite sem perfuração
Infectada	Presença de processo infeccioso ou tecido necrótico	Apendicite supurada/perfurada, drenagem de abscesso, fratura exposta antiga

18.6 Participação do técnico em enfermagem

O técnico em enfermagem **não integra a CCIH como membro executor** (exigência de nível superior), mas é peça fundamental na prevenção: adere às rotinas e protocolos (higiene das mãos, precauções, bundles, técnica asséptica), comunica à CCIH sinais de infecção e surtos, participa dos treinamentos, colabora com a coleta de culturas e com a manutenção de dispositivos invasivos e orienta pacientes e familiares.

2. PONTOS QUE MAIS CAEM EM PROVA

- Lei 9.431/1997 (obrigatoriedade) e Portaria 2.616/1998 (regulamentação).
- Membros consultores (médico, enfermagem, farmácia, microbiologia, administração) × executores (SCIH).
- 2 técnicos de nível superior por 200 leitos, 1 preferencialmente enfermeiro; enfermeiro 6 h/dia.
- Competências: programa, vigilância (busca ativa), surtos, uso racional de antimicrobianos, treinamento, notificação.
- Infecção comunitária × hospitalar; critério de 72 h; exceções no RN.
- Indicadores: taxa de IH e densidade de incidência por 1.000 dispositivos-dia.
- Classificação das cirurgias (limpa, potencialmente contaminada, contaminada, infectada).

3. MACETES E DICAS DE MEMORIZAÇÃO

- **"Lei 9.431 cria, Portaria 2.616 detalha"**.
- **Consultores: "MEFMA"** – Médico, Enfermagem, Farmácia, Microbiologia, Administração.
- **"Dois para duzentos"**: 2 executores de nível superior para cada 200 leitos.
- **"Enfermeiro 6, os outros 4"**: horas diárias dos executores.
- **"72 h separam a comunidade do hospital"**.
- **"Bebê nasceu com a infecção da placenta? Comunitária"**.
- **"Limpa mede a qualidade"**: taxa de ISC em cirurgias limpas.

4. QUESTÕES

QUESTÃO 01

A lei que tornou obrigatória a manutenção de um Programa de Controle de Infecções Hospitalares pelos hospitais do país é a:

(A) Lei nº 8.080/1990.
(B) Lei nº 9.431/1997.
(C) Lei nº 7.498/1986.
(D) Lei nº 10.216/2001.
(E) Lei nº 8.142/1990.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – é a Lei Orgânica da Saúde.

B) Correta – a Lei 9.431/1997 obriga os hospitais a manter o PCIH.

C) Incorreta – trata do exercício profissional da enfermagem.

D) Incorreta – trata da saúde mental.

E) Incorreta – trata da participação da comunidade e do financiamento do SUS.

QUESTÃO 02

Conforme a Portaria nº 2.616/1998, os membros executores da CCIH representam o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar e devem ser, no mínimo:

(A) 1 técnico de enfermagem para cada 50 leitos.
(B) 2 técnicos de nível superior da área da saúde para cada 200 leitos ou fração, sendo um deles preferencialmente enfermeiro.
(C) 5 médicos infectologistas por hospital.
(D) 1 administrador para cada 100 leitos.
(E) representantes de todos os setores, sem exigência de formação.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – os executores são de nível superior.

B) Correta – é o dimensionamento mínimo da portaria.

C) Incorreta – não há essa exigência.

D) Incorreta – o administrador integra os membros consultores.

E) Incorreta – há exigência de nível superior na área da saúde.

QUESTÃO 03

Paciente internado para tratamento clínico desenvolve pneumonia no 5º dia de internação, sem evidência de que estivesse em incubação na admissão. Essa infecção é classificada como:

(A) comunitária.
(B) hospitalar (relacionada à assistência).
(C) transplacentária.
(D) endógena comunitária.
(E) não classificável.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – a infecção comunitária está presente ou em incubação na admissão.

B) Correta – manifestação após 72 h da admissão, sem incubação prévia, caracteriza infecção hospitalar.

C) Incorreta – transplacentária refere-se a infecções do recém-nascido.

D) Incorreta – a origem endógena não define a classificação como comunitária.

E) Incorreta – a classificação é possível pelos critérios da portaria.

QUESTÃO 04

Uma herniorrafia inguinal eletiva, sem processo infeccioso e sem abertura de tratos colonizados, é classificada como cirurgia:

(A) limpa.
(B) potencialmente contaminada.
(C) contaminada.
(D) infectada.
(E) suja.

✔️ **GABARITO: A**

Comentário:

A) Correta – não há penetração em tratos colonizados nem infecção, caracterizando cirurgia limpa.

B) Incorreta – a potencialmente contaminada envolve abertura de tratos colonizados.

C) Incorreta – a contaminada envolve tecidos traumatizados ou falhas técnicas grosseiras.

D) Incorreta – a infectada envolve processo infeccioso presente.

E) Incorreta – "suja" não é a denominação adotada pela Portaria 2.616/1998, que utiliza "infectada".

QUESTÃO 05

Entre as competências da CCIH/CCIRAS, inclui-se:

(A) prescrever antibióticos para todos os pacientes internados.

(B) realizar a vigilância epidemiológica das infecções, investigar surtos e definir a política de uso racional de antimicrobianos.
(C) realizar diretamente a limpeza terminal dos quartos.
(D) punir os profissionais responsáveis pelas infecções.
(E) substituir a vigilância sanitária municipal.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – a CCIH orienta o uso racional, mas a prescrição é do médico assistente.

B) Correta – vigilância, investigação de surtos e política de antimicrobianos são competências da comissão.

C) Incorreta – a limpeza é executada pelo serviço de higienização, com normas propostas pela CCIH.

D) Incorreta – o foco é a prevenção e a educação, não a punição.

E) Incorreta – a CCIH coopera com a vigilância sanitária, sem substituí-la.

5. REVISÃO DO CAPÍTULO

Resumo em tópicos: Lei 9.431/1997 e Portaria 2.616/1998; PCIH; composição (consultores e executores); competências; classificação das infecções; indicadores; classificação das cirurgias; participação do técnico.

Quadro-resumo: 2 executores de nível superior para 200 leitos; enfermeiro 6 h/dia; IH após 72 h; densidade de incidência por 1.000 dispositivos-dia; ISC em cirurgia limpa como indicador de qualidade.

Pegadinhas: técnico como membro executor; achar que a CCIH prescreve antibióticos; classificar infecção transplacentária do RN como hospitalar.

Erros comuns: confundir consultores com executores; inverter a Lei 9.431 e a Portaria 2.616.